

위축성 위염·장상피화생 — 1년마다 내시경을 보는 이유

오늘 내시경에서 위축성 위염 또는 장상피화생이라는 말을 들으셨다면, 무엇이 문제이고 왜 정기적으로 내시경을 계속 보아야 하는지 설명드립니다.

위축성 위염·장상피화생이란

위축 — 위 점막이 얇아지는 변화입니다. 위축이 위 몸통 쪽까지 넓게 퍼진 **개방형(open type)**부터 위암 위험이 뚜렷하게 높아집니다.

장상피화생 — 위축이 진행된 자리에서 위 점막 일부가 **장 점막처럼 바뀐 상태**입니다.

연령별 유병률(내시경 소견 기준) — 국내 전국 다기관 연구에서 연령이 증가함에 따라 크게 늘어납니다.

· 위축성 위염: 40세 미만 29.9% → 60세 이상 59.4%

· 장상피화생: 40세 미만 3.4% → 60세 이상 17.4%

위암 위험, 얼마나 커지나요

장상피화생이 있으면 위암 위험이 올라가는 것은 맞습니다 — 국내 한 연구에서는 없는 경우보다 위암 발생이 **약 11배** 높게 나타났습니다.

하지만 원래 건강한 위에서 위암이 생길 확률이 워낙 낮아, 11배라 해도 **장상피화생이 있는 분의 대부분에서는 위암이 생기지 않습니다.**

실제 해외 자료(네덜란드 전국 병리 연구)에 따르면 장상피화생 진단 뒤 위암 발생은 **1년에 약 0.25%(400명 중 1명꼴)** 수준입니다.

지나치게 불안해하지 마시고 정기 검사를 잘 챙기시면 됩니다.

왜 정해진 간격으로 내시경을 보나요

정기 내시경은 **암을 막는 것이 아니라, 암이 생기더라도 이른 단계에서 빨리 찾는 것**입니다. 국가암검진 기준(**40세 이상 2년마다**)은 누구나 지켜야 하는 최소 간격입니다.

위축·장상피화생의 **범위와 정도**에 따라 이보다 짧은 **1년 간격**을 권해드리는 경우가 있습니다. 얼마나 자주 볼지는 검사 소견을 보고 **진료 때 개별적으로 정합니다.**

생활습관과 헬리코박터

위축·장상피화생이 있는데 **헬리코박터균까지 있으면 위암 위험이 더해지므로 제균 치료를 적극적으로 권합니다**(장상피화생이 없어지기 전, 일찍 할수록 좋습니다).

위에 좋은 것을 챙겨 먹기보다, **위에 나쁜 것 — 술·담배·짜고 매운 음식**을 줄이는 것이 더 중요합니다.

마·양배추즙 등이 위축이나 장상피화생을 되돌린다는 근거는 없습니다.

이런 증상은 검진 예정일까지 기다리지 마세요

검은 변·피를 토함 — 위장 출혈 가능성, 응급실(119)로

원인 모를 체중 감소

음식을 삼키기 어렵거나 걸리는 느낌이 계속됨

계속되는 구토

어지럼·빈혈이라는 말을 들음

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일 · 공휴일 휴진

근거 — ACG 위암 전암성 병변 진료지침(2025) · MAPS III 유럽·아시아 위암 감시 지침(2025) · AGA 위축성 위염 진료 업데이트(2021) · 국내 헬리코박터 파일로리 감염 진단·치료 지침(2025 개정판) · 국가암검진 위암검진 권고안 · 국내 유병률 Gut Liver 2013 · 개방형 위축 Digestion 2015 · 절대위험 Gastroenterology 2008. 내시경 간격은 검사 소견에 따라 담당의가 개별적으로 정합니다. 본 안내는 일반 건강정보이며 개인별 진단·검사 계획을 대신하지 않습니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/atrophic-gastritis-im/